



შინაწესები, განკვეთი, გირჩეები



პირადი ღაჯღჟჟის სისტემის პრობლემები: ღაქასასიათაქელი ნაქლი თუ აღქინისტრირების პრობლემები?

ნანა ბენიძე

ეკონომიკის დოქტორი
ანსუ ასოცირებული პროფესორი

ჯამბულ ბინაძე

ეკონომიკის დოქტორი
ანსუ ასოცირებული პროფესორი

„თითოეულ ადამიანს აქვს ჯანმრთელობის უმაღლესი სტანდარტის უფლება, რომელიც მისი ცხოვრების ღირსეულ პირობებს უზრუნველყოფს“ - ნათქვამია სახალხო დამცველის 2012 წლის ანგარიშში, სადაც ასევე განმარტებულია, რომ ეფექტური ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა ჯანმრთელობის შესაძლო უმაღლესი სტანდარტის რეალიზაციის თანაბარ შესაძლებლობას უნდა უზრუნველყოფდეს.

ქვეყნის ჯანდაცვის პრიორიტეტულობის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი ჯანდაცვაზე ქვეყნის მთლიანი დანახარჯია. მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, საქართველო ამ მხრივ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნების მაჩვენებლებს შორის.

საქართველოში უამრავი სამეცნიერო ნაშრომი და კვლევაა წარმოებული, რომელიც არგუმენტირებულად ადასტურებს სადაზღვეო საქმიანობის, კონკრეტულად, კი სიცოცხლის დაზღვევის ინსტიტუტის გაუმართავ ფუნქციონირებას საქართველოში.

დღესდღეობით გავრცელებული სადაზღვეო კოპანიების მომსახურების სერვისები მერყეობს 5 ლარიდან 50 ლარამდე და ით-

ვალისწინებს სხვადასხვა მომსახურებას. ამ მომსახურებებიდან ყველაზე მოთხოვნადია ამბულატორიული გამკვლევები, რაც აღნიშნული სადაზღვევო კომპანიების მიერ ჩატარებული კვლევებით დასტურდება.

ამბოლატორიული გამოკვლევა და პირადი ექიმის კინსულტაცია შედის ყველაზე დაბალ მომსახურებაში. კვლევებით დასტურდება ასევე ის ფაქტიც, რომ დაზღვეული მოსახლეობის უმეტესობა სარგებლობს ყველაზე დაბალ ტარიფიან სერვისით, სწორედ ეს განაპირობებს ამბოლატორიული გამოკვლევების მოთხოვნას, რადგან მოსახლეობას მხოლოდ ამ საშუალებით სარგებლობა შეუძლიათ ისიც განსაზღვრული ლიმიტით და რიგის მიხედვით, განსაზღვრულია სამედიცინო დაწესებულება.

საინტერესოა ფინანსური კუთხეც, იხარჯება თუ არა მიზნობრივად საბიუჯეტო სახსრები, რომელიც გამოყოფილია მოქალაქეთა დასახმარებლად. კონტროლის პალატამ 2011 წელს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოს დაფინანსებით 2008—2010 წლებში განხორციელებული დაზღვევის პროგრამის აუდიტი ჩაატარა. კონტროლის პალატის ხელმძღვანელის, ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით, აუდიტის წინასწარი მონაცემები „საგანგაშო“ იყო. წინასწარი დასკვნის თანახმად, სადაზღვევო კომპანიებს 2008—2010 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 284 მილიონი ლარი გამოეყო დაახლოებით 808 000 ადამიანის ჯანმრთელობის დაზღვევისთვის; კონტროლის პალატის მონაცემებით, მოსახლეობის მომსახურებაზე აღნიშნული თანხის მხოლოდ 40% -მდე დაიხარჯა და დაზღვეულთა მხოლოდ მეხუთედს მოხმარდა.

“მკაცრი სახელმწიფო რეგულირების არარსებობის და სადაზღვევო კომპანიების არაკეთილსინდისიერი ქმედებების გამო, ბოლო სამი წლის მანძილზე ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამიდან სადაზღვევო კომპანიების მოგების მარჟამ 60%—ს გადააჭარბა. სადაზღვევო პროგრამის ნაკლოვანი მხარეებია სამედიცინო მომსახურების ხელოვნურად შეზღუდული ხელმისაწვდომობა და პროგრამით მოსარგებლეთა არასაკმარისი ინფორმირება,” ნათქვამია საქართველოს კონტროლის პალატის განცხადებაში.

მიუხედავათ იმისა, იყო თუ არა სადაზღვევო კომპანიების მიერ სახელმწიფო სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვა 2008-2010 წლებში საქართველოში, ფაქტი ერთია, რომ სადაზღვევო კომპანიები გაუმართავად ფუნქციონირებენ, რაც გამოხატულია მოსახლეობის უკმაყოფილების მაღალი დონით. უკმაყოფილებას დაზღვეული მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოთქვამდა, ესაა აღნიშნული მომსახურებით მოსარგებლე ადამიანების დაახლოებით 80 პროცენტი, ისინი უჩივიან სადაზღვევო კომპანიებს შემოთავაზებული მომსახურების გამო. ეს უკმაყოფილება მოდის იმ სერვისებით სარგებლობიდან, რომლებითაც ყველაზე მეტად სარგებლობს მოსახლეობა და წარმოადგენს ყველაზე გამოყენებად სერვისებს. სადაზღვევო კომპანიებთან მიმართებაში ძირითადი პრობლემები შემდეგი სახისაა:

- გამოკვლევებისათვის სამედიცინო დაწესებულებების თავისუფალი არჩევა;
- ამბოლათორიული მომსახურების დაბალი ხარისხი;
- რიგები სამედიცინო დაზღვევით გათვალისწინებულ სამედიცინო პუქტებში;
- ჯანმრთელობის დაზღვევით სარგებლობის, გამოყენების უცოდინრობა (ინფორმირების დაბალი დონე);
- უკმაყოფილება არაპროფესიონალურად განეული მომსახურებით;
- ასაკობრივი ნიშნით მოსახლეობის დაყოფა და ასაკობრივი ლიმიტის დაწესებით გამონეული უარყოფითი დამოკიდებულება. ასეთი გარემოებით კომპანიები ცდილობენ მოგების მიზნით რისკი შეამცირონ.

იმ მრავალრიცხოვან პრობლემებს იკვეთება უცნაური კიდეე ერთი გარემოება. ესაა სახელმწიფოს მიდგომა იმ ადამიანების მიმართ, რომელთაც ქვეყნის უმაღლესი ჯილდო ერგოთ. ისე მოხდა, რომ სახელმწიფომ რუსთაველის პრემიის ლაურეატები დააზღვია, სახელმწიფო პრემიის მფლობელები კი დაზღვევის მიღმა დატოვა, არადა, სამეცნიერო ელიტის ღირსეულ წარმომადგენლებს მხოლოდ სახელმწიფო პრემიებს ანიჭებენ, მხატვრებს, მოქანდაკეებს, მწერლებს, მუსიკოსებს და მსახიობებს კი - რუსთაველისა და სა-

ხელმწიფო პრემიებს. აქ აშკარად კურორტული სიტუაცია იქმნება, მაგალითად: ზაქარია ფალიაშვილი ცოცხალი, რომ ყოფილიყო და რუსთაველის პრემიის ლაურეატი გამხდარიყო, მისი დაზღვევის ხარჯებს სახელმწიფო ანაზღაურებდა, ივანე ჯავახიშვილის კი, თუ მას სახელმწიფო პრემიას მიანიჭებდნენ, დაზღვევაზე ეტყოდნენ უარს.

გამოიკვეთა კიდევ ერთი საინტერესო ტენდენცია, თუ წინა წლებში სოციალურად დაუცველ ფენებს შეეძლოთ თავად გაეკეთებინათ არჩევანი ამა თუ იმ სადაზღვევო კომპანიას შორის, რაც, რასაკვირველია, ინფორმაციული ვაკუუმის გამო არც ისე ადვილი იყო და რითაც, სხვათაშორის, კომპანიები გარკვეული სახის ხეირსაც ღებულობდნენ, უკვე 2010 წლის 18 აპრილს ჩატარებული ტენდერის საფუძველზე ბენეფიციარს მხოლოდ იმ კომპანიასთან უნევს საქმის დაჭერა, რომელმაც ტენდერში გაიმარჯვა. რაც შეეხება ტენდერს, სადაზღვევო კომპანიები გეოგრაფიული არეალის მიხედვით გადანაწილდნენ.

ერთი პრობლემის არსი იმაშიც მდგომარეობს, რომ ჩვენ მონესრიგებულ სახელმწიფოში რომ ვცხოვრობდეთ, აუცილებლად გვეცოდინებოდა, ვინ არიან სადაზღვევო კომპანიის მფლობელები, ვის ეკუთვნის საკონტროლო პაკეტი, შეიცვალენ თუ არა მეპატრონეები, როგორ გადანაწილდა მათ შორის წილები და, ასე შემდეგ. რასაკვირველია ასეთი რეალური ინფორმაციის მოპოვება არის თითქმის შეუძლებელი და საბაზრო ურთიერთობები ძირითადად დამყარებულია ჭორების შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე.

ასევე საინტერესო ტენდენცია შეინიშნება პირადი დაზღვევისას მედიკამენტებთან დამოკიდებულებაში, თუ რომელ მედიკამენტებს სთავაზობენ უფრო ხშირად პაციენტებს, ესაა სამამულო წარმოების, რომელიც იაფი ღირს თუ უცხოური, რომლის ღირებულება საგრძნობლად მაღალია? ამ საკითხის კვლევით აუცილებელია თავად სახელმწიფო იყოს დაინტერესებული, სახელმწიფო, რომელიც მართლა ცდილობს სადაზღვევო სფეროს განვითარებას. ამ შემთხვევაში საქმე ისაა, რომ როდესაც სამედიცინო დაზღვევაზე ვლაპარაკობთ, ყველა გზას პირდაპირ ფარმაცევტულ კომპანიებამდე მივყავართ, რადგან რეცეპტების უმრავლესობას ექიმები „ავ-

ერსისა“ და „პე-ეს-პეს“ ლოგოებით დამშვენებულ ბლანკებზე გვინერნ.

2013 წლის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამით მოსახლეობის უნივერსალური საბაზისო პაკეტით უზრუნველყოფა დაიგეგმა, რომელიც მოიცავს 6—დან 60 წლამდე ბენეფიციარებს რომლებსაც ჯერ არ მიუღიათ დაზღვევა. ეს პაკეტი სამ ეტაპად ხორციელდება. პირველი ეტაპი უკვე განხორციელდა რომელიც მოიცავს პირველად გადაუდებელ სტაციონალურ მომსახურებას, მეორე ეტაპი დაიწყო პირველი იენისიდან და დამატება გეგმიური სტაციონალური მომსახურება. ხოლო მესამე ეტაპი მოიცავს საყოველთაო დაზღვევას. ექსპერტების აზრით, თუ ეს პროგრამა სრულად განხორციელდა ქვეყანაში დღემდე მოქმედი ყველა სადაზღვევო პროგრამა დაიწყებს შეჩერებას. შეჩერდება უმწეოთა, პედაგოგების, პენსიონერების, ბავშვთა დაზღვევის პროგრამები და ყველა მოქალაქეს უნივერსალური საბაზისო პაკეტი გადაეცემა. შეჩერდება კორპორატიული დაზღვევით მოსარგებლე პირთა დაზღვევები. საქართველოში მილიონნახევარი ადამიანი კორპორატიული დაზღვევით სარგებლობს. ყველა ეს ადამიანი მომავალი წლიდან საბაზისო პაკეტს მიიღებს, რომელიც, პაკეტში განერილ მომსახურებაზე ყველა ადამიანს თანაბარ ხელმისაწვდომობას დაუდგენს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი ლაშა ნიკოლაძე იმ ადამიანებს ვისაც საშუალება აქვთ კერძო სადაზღვევო კომპანიის მომსახურებით ისარგებლოს, მხოლოდ სახელმწიფო დაზღვევის ხარჯზე დარჩენას არ ურჩევს.

ექსპერტების ნაწილს მიაჩნია, რომ სახელმწიფოს დახმარება მიმართული უნდა იყოს გაჭირვებაში მყოფი ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ, რომელთაც ამ დახმარების გარეშე სიღარიბე ემუქრებათ. შესაბამისად, დახმარება უნდა გავრცელდეს ყველაზე, რადგან უნივერსალურ დაზღვევას დიდი ფინანსური რესური სჭირდება, რომელიც ქვეყნის ბიუჯეტს ყოველწლიურად მძიმედ დააწვება.

როგორც ვხედავთ პირადი დაზღვევის კუთხით საკმაოდ მძიმე სურათი გვაქვს სახეზე საქართველოში. უამრავი წვრილმანი სფე-

როა, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირებას საჭიროებს. მომავალი ჩასატარებელი სამუშაოები მართლაც შრომატევად და დროში განელილ სამუშაო პროცესებს მოიცავს, სახელმწიფომ მართვის სისტემის დარეგულირებული მეთოდებით უნდა მიიღოს ოპტიმალური გადაწყვეტილებები და უზრუნველყოს ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობის პირადი დაზღვევის პერსპექტიული მოდელით უზრუნველყოფა.

ეს პროცესები რასაკვირველია არ არის ცალსახა, მასში აუცილებლად მოსახლეობის მაღალი ჩართულობა იგულისხმება, ბიზნეს პარტნიორებთან ერთობლივი მუშაობით უნდა შემუშავდეს ის ძირითადი მიდგომები, რომელიც განსაკუთრებით მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის ქვეყანას სოციალურ ტვირთს შეუმსუბუქებს და იქნება მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის გარანტი.